

1. Накладання шкірних швів ; апендицит

Сценарій.

Ви черговий хірург лікарні. Бригадою швидкої медичної допомоги до приймального відділення доставлена пацієнтка 19 років.

Скарги: на біль у правій здухвинній ділянці, нудоту, одноразовий рідкий стілець, загальну слабкість.

Анамнез захворювання: Захворіла за 15 годин до надходження, коли спочатку з'явилися болі в епігастрії, які через декілька годин мігрували у праву здухвинну ділянку.

Анамнез життя: Цукровий діабет, туберкульоз, гепатити, сифіліс, ВІЧ-інфекцію заперечує. Хворів ГРВІ. Операцій та травм не було. Алергічних реакцій немає.

Спадковість: необтяжена.

Об'єктивно: стан середньої тяжкості, у свідомості, положення – активне, з обмеженням. Шкіра блідо-рожева, суха. Ріст 170 см, вага 73 кг. Свідомість збережена. Грудна клітка симетрична, симетрично приймає участь в акті дихання. Над легенями аускультативно – везикулярне дихання. ЧДР – 18 за хвилину. Пальпаторно локальної болючості, підшкірної емфіземи грудної клітки не виявлено. Тони серця ритмічні, ясні. ЧСС 87 за хвилину, пульс симетричний на обох руках, АТ 120/80 мм рт ст. Язик підсушений, з білим нальотом. Живіт дещо підвдутий, симетричний. При пальпації визначається напруження м'язів внизу живота справа, позитивний симптом Щоткіна Блюмберга. Симптом Пастернацького негативних з обох боків. Сечовипускання не порушене. Сеча жовтого кольору. Стілець був напередодні, коричневого кольору. При ректальному дослідженні – патологічних об'ємних утворень не виявлено, болючість правої бокової стінки.

Додатково:

Клінічний аналіз крові

Показник	Значення	Норма
Гемоглобін (г/л)	142	120-140
еритроцити (10 ¹² /л)	4,7	3,9-4,7
Кольоровий показник	0,9	0,85-1,15
Тромбоцити (10 ⁹ /л)	215	180-320
Лейкоцити (10 ⁹ /л)	15,0	4,0-9,0
Лімфоцити %	13	19-37%

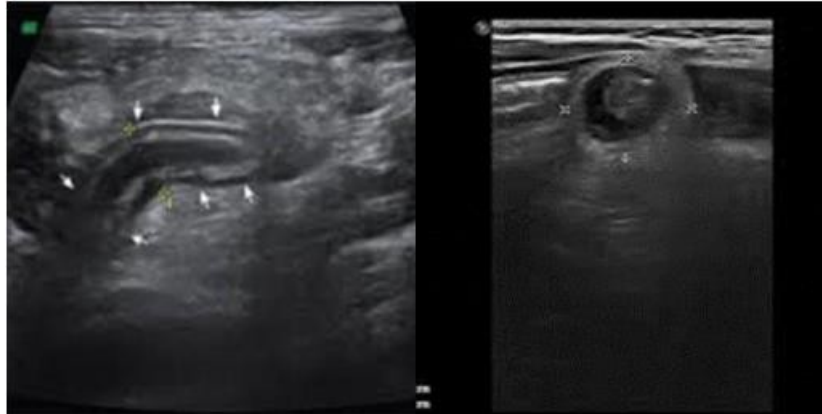
Еозинофіли %	1	0,5-5
Паличкоядерні нейтрофіли %	15	1-6%
Сегментоядерні нейтрофіли %	65	47-72%
Моноцити %	4	3-11%
ШЗЕ	20	5-15

Клінічний

Показник	Значення	Норма
Кількість	100 мл	
Колір	жовтий	світло- жовтий
Прозорість	Прозора	Прозора
Питома вага	1,010	1,010-1,040

Білок	нема	нема
Цукор	нема	нема
Мікроскопія сечового осаду	нема	нема
Лейкоцити	1-2 у п/з	6-8 у п/з
Еритроцити	1-2 у п/з	до 5 у п/з
Циліндри	нема	нема
Солі	нема	нема
Слиз	нема	нема
Бактерії	нема	нема

Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини.



№п/п	Дії	Текст
1.Комунікативні навички		
1.1	Привітатися.	Доброго дня.
1.2	Ви даєте свою згоду на проведення клінічного обстеження?	Так
Збір скарг та анамнезу		
2.1	Які у Вас скарги?	на біль у правій здухвинній ділянці, нудоту, однократний рідкий стілець, загальну слабкість.
2.2	Коли з'явилися скарги, що з Вами трапилось?	Захворіла за 15 годин до надходження, коли спочатку з'явилися болі в епігастрії, які через декілька годин мігрували у праву здухвинну ділянку. Після посилення болі викликала БШМД.
2.3	Якими захворюваннями перехворіли? Чи є алергія? Чи були операції?	Цукровий діабет, туберкульоз, гепатити, сифіліс, ВІЧ інфекцію заперечує. Хворів ГРВІ. Операцій та травм не було. Алергічних реакцій немає. Спадковість: необтяжена.
3.Об'єктивне обстеження		

3.1	Огляд з верифікацією виявлених патологічних змін.	Я проводжу огляд з верифікацією виявлених патологічних змін . Я бачу пацієнтку в положенні лежачи, вона обмежує рухи через біль. Шкіра блідо-рожева, суха, язик підсушений з білим нальотом. Пульс
		87 уд./хв., АТ 120/80 ммрт.ст. Загальний стан — середньої тяжкості.
3.2	Пальпація з верифікацією виявлених патологічних змін	Я виконую пальпацію з верифікацією виявлених патологічних змін При пальпації виявляю локальну болючість у правій здухвинній ділянці, м'язовий захист. Симптом Щьоткіна-Блюмберга позитивний. Також позитивні симптоми Ровзінга (біль в правій при пальп в лівій пдвздшн), Воскресенського(рубашка) та Образцова(підняв правую ногу).
3.3	Перкусія з верифікацією виявлених патологічних змін	Я виконую перкусію з верифікацією виявлених патологічних змін Перкуторно живіт звучить тимпанічно, перкуторна болючість у правій здухвинній ділянці. Ознак вільного газу під куполом діафрагми не виявлено (перкуторно).
3.4	Аускультация з верифікацією виявлених патологічних змін	Я виконую аускультацию з верифікацією виявлених патологічних змін Аускультативно вислуховується перистальтика кишечника, дещо ослаблена, без патологічних шумів. Ознак паралітичної кишкової непрохідності немає.
4.Діагностика		
4.1	Проаналізувати клінічний аналіз крові	Я аналізую клінічний аналізк рові Я виявляю лейкоцитоз ($15,0 \times 10^9/\text{л}$), зростання паличкоядерних нейтрофілів (15%) та ШОЕ (20 мм/год), що свідчить про гострий запальний процес. Лімфопенія (13%)
4.2	УЗД	Апендікс потовщений (норма до 6мм), з розширенням просвіту, потовщення стінки апендиксу.

4.3	Встановити попередній клінічний діагноз	Гострий апендицит. Флегмонозна форма.
5. Визначення тактики ведення та лікування		
5.1	Медикаментозна терапія, фізіотерапія, особливості харчування	Планова лапароскопічна або лапаротомічна апендектомія. До операції — інфузійна терапія, антибіотикопрофілактика (цефалоспорини), знеболення. Харчування — натще до моменту оперативного втручання.
6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6.1	Рекомендувати профілактичні заходи	Я рекомендую в майбутньому при будь-якому болю в животі не займатись самолікуванням, а звертатись за медичною допомогою. Також важливе своєчасне лікування ГРВІ, правильне харчування, уникнення запорів та зловживання шкідливою їжею.
7.Інше		
7.1	Інформування пацієнта про можливі ризики хвороби	Я інформую пацієнтку про можливі ризики хвороби Я поясню ризики несвоєчасного хірургічного втручання — перфорація апендикса, розвиток перитоніту, сепсису. Обговорюю хід та обсяг операції, можливі ускладнення, післяопераційний режим.

Чек-лист до практичної навички «Накладання шкірних швів»

№	Маніпуляція	Форма представлення
1	Коректне розташування пацієнт-лікар, встановлення контакту з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль)	Сказати
2	Отримати інформаційну згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Обробити руки антисептиком хірургічним способом (лікар в рукавичках)	Сказати

4	Коректно захопити голкотримач (домінантною рукою, розташувачи в кільцях голкотримача кінцеві фаланги I та IV пальців та фіксуючи місце поблизу перехрещення рукояток голкотримач кінцевою фалангою II) пальця	Виконати
5	Захопити голкотримачем голку, зарядити нитку в голку (фіксувати кінець нитки великим пальцем субдомінантної руки, домінантною рукою провести нитку під гострим	Виконати

	кінцем голки та під губками голкотримача, зверху протягнути нитку через вушко голки)	
6	Коректно захопити пінцет (субдомінантною рукою за типом письмового пера: кінцеві фаланги II, III пальців з одного боку, кінцева фаланга I пальця з іншого боку)	Виконати
7	Коректна фіксація одного краю рани пінцетом (захопити пінцетом далекий від хірурга край рани, відвести край рани пінцетом назовні та догори)	Виконати
8	Коректне проведення голки та шовного матеріалу за допомогою голкотримача в направленні згідно з типом шва)	Виконати
9	Формування вузла (мануально, за допомогою інструментів). Відсічення країв нитки на відстані 1-1,5 см від вузла	Виконати

